

Prothèse pénienne gonflable (IPP)

WARWIKI

Information pour le patient · Ce que vous devez savoir avant votre implant pénien

Une prothèse pénienne gonflable (IPP) est un dispositif entièrement placé sous la peau qui vous permet d'obtenir une érection ferme quand vous le souhaitez — pour les hommes dont la dysfonction érectile n'a pas répondu aux médicaments, aux injections ou aux autres traitements. Vous la commandez grâce à une pompe dissimulée dans le scrotum. Ce document explique son fonctionnement, comment vous préparer et à quoi vous attendre.

À propos de cette intervention

Lorsque la **dysfonction érectile (DE)** ne répond pas aux médicaments, au dispositif de vacuum ni aux injections, l'implant est l'étape suivante la plus fiable, avec un taux de satisfaction très élevé. Un dispositif en trois parties est mis en place, entièrement sous votre peau :

- Deux **cylindres** souples à l'intérieur du pénis, qui se remplissent de liquide pour le rendre ferme
- Une **pompe** dans le scrotum que vous pressez pour gonfler et appuyez pour dégonfler
- Un **réservoir** de liquide dans le bas-ventre

Utilisation : pressez la pompe plusieurs fois pour remplir les cylindres et obtenir une érection ; appuyez sur la soupape de décharge pour revenir au repos. Vous décidez quand et pour combien de temps.

Ce qu'il faut savoir

C'est un **choix permanent**. La pose de l'implant modifie le tissu érectile : après l'intervention, les érections naturelles et les autres traitements (médicaments, injections) ne fonctionnent plus — l'implant devient votre façon d'obtenir une érection. Il ne modifie **pas la miction, la sensibilité, l'orgasme ni l'éjaculation**. Comme tout implant, il comporte certains risques — principalement l'infection — et peut s'user après plusieurs années et nécessiter un remplacement.

COMPRENDRE LES TERMES

Dysfonction érectile (DE)

Difficulté à obtenir ou maintenir une érection suffisamment ferme pour les rapports sexuels.

Prothèse pénienne (IPP)

Le dispositif implanté qui produit une érection à votre demande.

Cylindres

Les deux parties placées dans le pénis qui se remplissent de liquide pour le rendre ferme.

Pompe

La partie dans le scrotum que vous pressez pour gonfler et appuyez pour dégonfler.

Réservoir

Le contenant de liquide placé dans le bas-ventre.

Activation

La consultation ~4–6 semaines après la chirurgie où le dispositif est utilisé pour la première fois et où vous apprenez à le manœuvrer.

Cyclage

Gonfler et dégonfler quotidiennement après la guérison — maintient le bon fonctionnement et préserve la longueur.

Anesthésie générale

Médicament qui vous endort et supprime la douleur pendant la chirurgie.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? La chirurgie se fait sous anesthésie générale ou rachidienne : vous ne sentez rien pendant l'intervention. Ensuite, le pénis et le scrotum sont douloureux, gonflés et marqués de bleus pendant quelques semaines — suspensoir, glace et antalgiques aident. L'opération dure environ une heure ; beaucoup rentrent le jour même.

Comment vous préparer (Avant la chirurgie)

- Réalisée sous **anesthésie générale ou rachidienne** — suivez toutes les consignes préopératoires (jeûne, médicaments à suspendre, y compris les anticoagulants).
- **La prévention de l'infection est essentielle** : toute infection (y compris urinaire) est traitée au préalable ; vous vous douchez avec un savon antiseptique et recevez des antibiotiques.
- **Ne fumez pas et ne vapotez pas** ; si vous avez du **diabète**, votre équipe voudra une glycémie bien contrôlée — ces deux mesures réduisent le risque d'infection.

Signalez à votre équipe à l'avance si vous :

- Avez du **diabète** ou des difficultés à utiliser vos mains (vous actionnez vous-même la pompe)
- Avez déjà subi une chirurgie pelvienne ou pénienne, une radiothérapie, ou avez un implant antérieur

Déroulement de la chirurgie

- 1 Vous êtes endormi ou insensible de la taille vers le bas sous anesthésie, et des antibiotiques sont administrés.
- 2 Par une petite incision (près du scrotum ou du bas-ventre), le chirurgien place les **cylindres** dans le pénis, la **pompe** dans le scrotum et le **réservoir** dans le bas-ventre — tout sous la peau.
- 3 Le dispositif est testé, puis laissé dégonflé le temps de la cicatrisation. Une sonde peut être posée brièvement.

Après la chirurgie

- Portez un suspensoir scrotal, appliquez de la glace, prenez des antalgiques et gardez l'incision propre et sèche.
- **N'utilisez pas le dispositif et n'ayez pas de rapports avant l'accord du chirurgien** — en général **4–6 semaines**. À la **consultation d'activation**, il est gonflé pour la première fois et l'on vous apprend à manœuvrer la pompe.
- Ensuite, faites le « **cyclage** » **quotidien** les premiers mois — cela préserve le fonctionnement et la longueur.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons, ou une rougeur, douleur ou écoulement croissant à l'incision
- Une impossibilité d'uriner
- Une douleur intense ou croissante, ou un pénis qui prend une couleur sombre ou bleutée

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'IPP est un dispositif discret pour la DE résistante aux autres traitements — pressez la pompe scrotale pour une érection, appuyez sur la soupape pour revenir au repos.
2. C'est un **choix permanent** (érections naturelles, médicaments et injections ne fonctionneront plus après), mais il ne **modifie pas la miction, la sensibilité, l'orgasme ni l'éjaculation**.
3. La prévention de l'infection est primordiale — traitez toute infection, ne fumez pas, utilisez le savon antiseptique et les antibiotiques. N'utilisez pas le dispositif avant l'activation (~4–6 semaines).